ICS 11.020
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.12—2009

针灸技术操作规范　第12部分：火针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 12：Fire acupuncture

2009-02-06 发布　　2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为21个部分：

——第1部分：艾灸；
——第2部分：头针；
——第3部分：耳针；
——第4部分：三棱针；
——第5部分：拔罐；
——第6部分：穴位注射；
——第7部分：皮肤针；
——第8部分：皮内针；
——第9部分：穴位敷贴；
——第10部分：穴位埋线；
——第11部分：电针；
——第12部分：火针；
——第13部分：芒针；
——第14部分：锓针；
——第15部分：眼针；
——第16部分：腹针；
——第17部分：鼻针；
——第18部分：口唇针；
——第19部分：腕踝针；
——第20部分：毫针基本刺法；
——第21部分：毫针针刺手法。

本部分为GB/T 21709的第12部分。

本部分的附录A、附录B为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分起草单位：北京针灸三通法研究会。

本部分主要起草人：贺普仁、曲延华、贺林、王京喜、徐春阳、程海英、谢新才。

针灸技术操作规范　第12部分:火针

1　范围

GB/T 21709的本部分规定了火针刺法及火针操作的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项及禁忌。

本部分适用于火针刺法的技术操作。

2　术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T 21709的本部分。

2.1

火针　fire needle

用耐受高温并对人体无伤害的金属为材料,供烧红使用的针具。

2.2

火针刺法　fire needle therapy

烧红火针针体,按一定刺法迅速刺入人体选定部位的针刺方法。

3　操作步骤与要求

3.1　施术前准备

3.1.1　针具选择

3.1.1.1　火针针具选择

针尖应圆利、无倒钩;针体应光滑、无锈蚀;针柄与针体缠绕应牢固,无松动。

火针的结构、材质、规格参见附录A。

3.1.1.2　烧针工具选择

点燃酒精灯,用于针体加热;或用其他安全方式加热针体。

3.1.2　部位选择

根据适应证病情可选取腧穴、血络、体表病灶或病灶周围等部位,并在选定的针刺部位上加以标记,以确保针刺的准确性。火针刺法适应证参见附录B。

3.1.3　体位选择

根据病情及针刺部位,可选择患者舒适安全,医者便于操作的体位。

3.1.4　环境要求

治疗环境应清洁卫生,远离易燃物,并注意避风。

3.1.5　消毒

3.1.5.1　医者消毒

医者双手应先用肥皂水清洗干净,再用75%乙醇擦拭。

3.1.5.2　针刺部位消毒

可用75%乙醇或0.5%～1%碘伏棉球在针刺部位消毒。

3.1.5.3　火针针体消毒

点燃酒精灯,从针根沿针体到针尖连续移动烧红,对施术前针体消毒。

3.2　施术方法

3.2.1　针体加热

用酒精灯烧红针尖及针体,根据针刺深度,决定针体烧红长度。

3.2.2 进针

针体烧红后，应迅速、准确地刺入针刺部位。

3.2.3 火针常用刺法

3.2.3.1 点刺法

在腧穴上施以单针点刺的方法。

3.2.3.2 密刺法

在体表病灶上施以多针密集刺激的方法，每针间隔不超过 1 cm。

3.2.3.3 散刺法

在体表病灶上施以多针疏散刺激的方法，每针间隔 2 cm 左右。

3.2.3.4 围刺法

围绕体表病灶周围施以多针刺激的方法，针刺点在病灶与正常组织交界处。

3.2.3.5 刺络法

用火针刺入体表血液淤滞的血络，放出适量血液的方法。

3.2.4 出针

针体达到治疗深度后，即可出针。

3.3 施术后处理

3.3.1 消毒针具

为避免由针体产生的交叉感染，应重新用酒精灯从针根沿针体到针尖连续移动烧红，消毒备用。

3.3.2 处置针孔

为减轻疼痛，促进愈合，应妥善处置针孔：

a) 可用无菌棉球或棉签按压针孔；

b) 针孔如有出血或渗出物，可用无菌棉球擦拭按压；

c) 火针刺络出血后，可用敞口器皿承接，待出血停止后，再用无菌棉球擦拭按压。

4 注意事项

4.1 施术时应注意安全，防止烧伤或火灾等事故发生。

4.2 针刺要避开动脉及神经干，勿损伤内脏和重要器官。

4.3 孕妇、产妇及婴幼儿慎用。

4.4 糖尿病患者、瘢痕体质或过敏体质者慎用。

4.5 精神过于紧张、饥饿、疲劳的患者不宜用。

4.6 施术后，医者应向患者说明术后针刺部位的维护事项，包括：

a) 针孔局部若出现微红、灼热、轻度疼痛、瘙痒等症状属正常现象，可不作处理；

b) 应注意针孔局部清洁，忌用手搔抓，不宜用油、膏类药物涂抹；

c) 针孔当天不宜着水。

5 禁忌

5.1 不明原因的肿块部位。

5.2 大失血、凝血机制障碍的患者。

附 录 A
（资料性附录）
火 针 针 具

A.1 火针结构

A.1.1 针尖

火针前端尖利部分为针尖。由于火针在烧红状态下使用，针尖反复烧灼，易变脆折断，因此要求针尖利而不锐，稍圆钝为佳。

A.1.2 针体

针尖至针根的中间部分为针体。针体烧红时进针，容易变形弯曲，因此要求针体应坚硬、挺直、有弹性、表面光滑，使进出针顺畅。

A.1.3 针根

针体与针柄连接处为针根，是针体消毒的起始部位。

A.1.4 针柄

火针后部手指持针处为针柄。针柄宜用铜质材料缠制成环柄盘龙式针柄，使其具有隔热性，便于施术操作。

A.2 火针材质

火针针具在高温下使用，要求制作火针针体的材料在高温烧灼条件下，应具备坚硬、不弯曲、有弹性、对人体无伤害的特点，理想的材质宜采用钨基高比重硬质合金材料。

A.3 火针规格

火针疗效与针体的粗细长短有一定关系。临床上应根据不同病症，不同穴位，选择不同规格的火针。一般火针规格如下：

a） 针体直径可选用 0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、0.6 mm 或其他适合的直径；

b） 针体长度可分为 20 mm、30 mm、40 mm 或其他适合的长度。

附　录　B
（资料性附录）
火针刺法适应证

B.1　内科

头痛、眩晕、不寐、痹证、发热、面肌痉挛、面痛、面瘫、哮喘、中风、高血压、痛风、痿证、脘腹痛、胁肋疼痛、肠炎、呃逆等。

B.2　外科、骨伤科

扭伤、腰腿痛、腰椎病、关节炎、腱鞘囊肿、网球肘、筋膜炎、颈椎病、代偿性骨质增生、痄腮、静脉曲张、胎记、痔疮等。

B.3　妇科

乳腺炎、乳腺增生、痛经、月经不调、子宫肌瘤、卵巢囊肿、外阴白斑等。

B.4　皮肤科

湿疹、皮炎、带状疱疹、黄褐斑、痤疮、银屑病、荨麻疹、神经性皮炎、白癜风等。

B.5　五官科

麦粒肿、牙痛、舌肿、咽喉肿痛、鼻瘜肉、过敏性鼻炎等。